

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: III.6 - 23	Bezeichnung des Dokumentes: Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte/Pflegehilfskräfte

Definition Sturz:

- Ein Sturz ist ein Ereignis, bei dem der Betroffene unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf einer anderen tieferen Ebene aufkommt.“
- Damit sind außer Stürze, die den ganzen Körper zu Boden bringen, auch solche Sturzereignisse eingeschlossen, nach denen die Person z.B. in der Hocke oder im Sitzen aufkommt

Definition Sturzprophylaxe:

- Das individuelle Sturzrisiko eines Patienten ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Es ist unsere Aufgabe, diese Faktoren zu identifizieren, ihre Bedeutung einzuschätzen und dann geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Unter Sturzprävention werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die entweder das Sturzrisiko reduzieren oder die Folgen eines Sturzes mildern. Darunter fällt etwa die Beurteilung der Sturzrisikofaktoren, Einweisung von Patienten in die Verwendung von Mobilitätshilfsmitteln, die Kontrolle der Hör- und Sehfähigkeit sowie die Beseitigung von potentiellen Unfallquellen.

Pflegeziel:

- Jeder Patient mit einem erhöhten Sturzrisiko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze weitgehend verhindert und Sturzfolgen minimiert.
- Das Sturzrisiko wird korrekt bestimmt
- Der Bewohner ist motiviert, sich aktiv an der Sturzvermeidung zu beteiligen.
- Die Wohnumgebung bietet eine maximale Sicherheit.

Indikation:

- zur Sturzprophylaxe bzw.
- bei/nach Stürzen

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Bewohner

Vorbereitung:

- Das Pflegepersonal wird regelmäßig zum Thema Sturzprävention fortgebildet.
- Das Pflegepersonal wird regelmäßig über aktuelle Hebe- und Transfertechniken informiert.
- Wir beschaffen regelmäßig aktuelle Literatur zum Thema Sturzprävention
- Alle Bewohner erhalten die notwendigen Mobilitätshilfen
- Wir stellen sicher, dass alle Mitarbeiter ausreichend zeitliche Ressourcen erhalten, um Stürze auszuwerten und zu analysieren.

Durchführung:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Veränderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2020	06.02.2023	003	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: III.6 - 23	Bezeichnung des Dokumentes: Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“	

Allgemein:

- Anwendung der Sturzrisikoerhebung
- grundsätzlich **durch die PFK** anzuwenden bei Aufnahme, bei Veränderungen in den Ursachen/Risiken und nach jedem Sturz sowie bei der Evaluation der Pflegeplanung
- die Bewertung mit der Sturzrisikoskala ersetzt keine klinische Bewertung/
Krankenbeobachtung
- das Selbstbestimmungsrecht des Bewohners ist zu beachten, bei Einbindung von Angehörigen ist vorher die Genehmigung durch den Bewohners einzuholen

Beratung:

- Jeder Bewohner sowie seine Angehörigen werden regelmäßig über das individuelle Sturzrisiko informiert
- Die Durchführung von Beratungen wird dokumentiert
- Wir prüfen, welche Mobilitätshilfsmittel der Bewohner nutzen sollte, also etwa Gehwagen, Unterarmgehstützen usw.
- Wir weisen Rollstuhlfahrer auf besondere Sicherheitsmaßnahmen hin. Etwa:
 - Vor dem Ein- und Aussteigen werden alle Bremsen festgestellt.
 - Sollte eine Bremse einen Defekt haben, darf der Rollstuhl nicht mehr genutzt werden, bis eine Reparatur erfolgt.
 - Beim Transfer werden die Fußstützen weg geklappt.
 - Wenn der Rollstuhl beim Transfer häufig nach vorne weg kippt, wird er mit einer entsprechenden Kippsicherung oder mit Gewichten an der Rückseite ausgestattet.
 - Ggf. wird der Rollstuhl mit einer rutschfesten Sitzauflage ausgestattet.

Organisatorische Faktoren:

- Patientenzimmern dürfen sich keine Hindernisse befinden
- instabile Einrichtungsgegenstände werden nach Möglichkeit entfernt (Schemel, leichte Blumensäulen usw.)
- Verschüttete Flüssigkeiten werden sofort und vollständig aufgewischt und der Boden gründlich getrocknet.
- Zimmer sind gut ausgeleuchtet. Das gilt ganz besonders für den Abend und die Nacht.
- Die Höhe des Bettes ist individuell an den Bewohner angepasst. Er muss leicht ein- und aussteigen können oder dem Transfer angepasst
- Wir überprüfen regelmäßig, ob die Nutzung von Bettgittern eine angemessene Risikominderung erbringen könnte
- Die Räder jedes Pflegebettes sind stets arretiert
- Im Badezimmer gibt es zusätzliche Haltegriffe. Die Festigkeit von allen Haltegriffen wird regelmäßig überprüft

körperliche Einschränkungen, die das Sturzrisiko erhöhen:

- Es wird erfragt, ob es vor dem Aufenthalt bereits Stürze gab (zu Hause, im Krankenhaus)
- Es wird geprüft, ob bei Patient Gangstörungen erkennbar sind (etwa: Haltungsstörung, Gangunsicherheit)
- Patient mit nächtlichem Harndrang werden ggf. stets auf die Toilette begleitet

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Veränderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2020	06.02.2023	003	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: III.6 - 23	Bezeichnung des Dokumentes: Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“	

- Es wird geprüft, ob bei Patient Sehstörungen oder Augenerkrankungen bekannt sind. Die Auswirkung einer dementiellen Erkrankung auf die Sturzgefahr wird regelmäßig überprüft. Ggf. wird ein Facharzt für Geriatrie oder Psychiatrie konsultiert.
- Es wird geprüft, ob der Patient Medikamente einnimmt, die als Nebenwirkung u. a. auch Schwindel oder niedrigen Blutdruck verursachen können.
- Die unteren Extremitäten werden regelmäßig auf etwaige Funktionsstörungen überprüft (Muskelschwäche, Arthrose, periphere Neuropathie, Fußdeformitäten). Es wird geprüft, ob Patient insbesondere Probleme mit den Füßen haben (etwa: Hühneraugen, Hammerzehen oder eingewachsene Nägel)
- Es wird geprüft, ob ein Patient Angstreaktionen bei weiten Gehstrecken zeigt
- Wenn ein Patient unter Depressionen leidet, achten die Pflegekräfte verstärkt auf alle krankheitsbegleitenden Faktoren, die Stürze begünstigen. (Schlaflosigkeit, Gewichtsverlust, Irritierbarkeit usw.)

Maßnahmen der Sturzprophylaxe können sein:

- Feststellung von Vorlieben bzw. Ablehnungen im Rahmen der Umsetzung sturzprophylaktischer Maßnahmen
- die Pflegeplanung stellt den individuellen Maßnahmeplan dar, innerhalb der Pflegeplanung sind adäquate Maßnahmen zu den personenbezogenen, medikamentenbezogenen und umgebungsbezogenen Risiken zu vereinbaren
- bei der Evaluation/Überarbeitung der Pflegeplanung sind die festgestellten Risiken und neu hinzu gekommene Risiken zu beachten
- externe Personen wie der Arzt/Augenarzt bzw. Physiotherapeut/Ergotherapeut sind über das Sturzrisiko zu informieren, zu weiteren individuell notwendigen Maßnahmen ist sich abzustimmen
- Die PFK/PK koordiniert notwendige Aktivitäten mit Dritten und informiert bei Notwendigkeit die PDL
- im Rahmen des Entlassungsmanagement in andere Versorgungsformen ist auf das Sturzrisiko hinzuweisen (prophylaktische Maßnahmen oder ggf. zu unterlassende Maßnahmen)
- Patienten und Angehörige sind zu den festgestellten Risiken in emphatischer und verständlicher Form zu beraten und zu informieren. Sind Patienten oder Angehörige kognitiv nicht fähig den Inhalt zu verstehen und Hinweise umzusetzen bzw. sind Angehörige nicht erreichbar oder lehnen eine Beratung ab, so ist das Beratungsblatt einzulegen, im freien Textfeld sind die unternommenen Beratungsaktivitäten einzutragen. Die PFK/PHK handelt dann als Assistenz
- Patient und Angehörige sind bei der Umsetzung zu unterstützen
- Beobachtung und pflegefachliche Bewertung von Beinahe-Stürzen
- Anregung zur Überprüfung und Anpassung der Medikation durch den Arzt
- Unterstützung bei der Anpassung von neuen Brillen bzw. Gläsern
- Die PFK/PK empfiehlt mögliche Anpassungen der Umgebung z. B. Überprüfung und Anpassung der Lichtverhältnisse, der Sitzmöbel, des Bettes, der Toilette, der Dusche oder Badewanne und des Fußbodens sowie das Anbringen von Haltegriffen, Beseitigung von Stolperfallen, Einsatz geeigneter Hilfsmittel, Benutzung rutschfester Unterlagen
- **Hilfsmittel zur Sturzprävention könnten sein:** **Gehhilfen:** verschiedene Gehstöcke, Rollatoren, Stoppersocken, Schuhspikes, **Mobilitätshilfen:** höhenverstellbares Bett, WC-Sitzerhöhung, Badewannen-Einstiegshilfe, Stütz- und Haltegriffe **Alltagshilfen:** lange Schuhlöffel, Strumpfanzieher, Greifzange, Badewannensitz **Hebehilfen:** Mobilisationsgürtel, Rutschbrett, Aufstehhilfe, Lifter **technische Hilfen:** Alarmgeber,

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Veränderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2020	06.02.2023	003	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: III.6 - 23	Bezeichnung des Dokumentes: Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“	

Falldetektoren, Sensormatten, Bewegungsmelder **Reduktion von Verletzungen:**
Hüftprotektoren, Sturzhelme, Niedrigstbetten, Auffangmatten

- Anbieten von Schulungen/ Einweisungen in die bewusste und ordnungsgemäße Handhabung von Hilfsmitteln (bspw. Rollatoren und andere Hilfsmittel etc.)
- Anpassung Schuhwerk, Empfehlungen für besonderes Schuhwerk
- Unterstützung bei Toilettengängen
- im Ausnahmefall kann es im Rahmen der Sturzprophylaxe auch zum bewussten Einsatz freiheitseinschränkender/freiheitsentziehender Maßnahmen kommen, hierbei ist nach dem hierfür geltenden Standard zu verfahren – besitzt der Bewohner keine Eigenbewegung mehr kann das Ziehen des Bettgitters als Maßnahme der Sturzprophylaxe geplant werden ansonsten ist der Einsatz von FEM im Rahmen der Sturzprophylaxe nicht zulässig

nach einem Sturz:

- der Bewohner ist anzusprechen, die Vitalzeichen sind zu erheben, lebensrettende Maßnahmen sind umzusetzen
- bei Notwendigkeit sofort den Notarzt verständigen
- es ist ein Sturzprotokoll zu führen und an die PDL weiter zu leiten, die Sturzrisikoerhebung ist zu aktualisieren
- die PDL führt eine Gesamtliste der Sturzereignisse mit der Darstellung von Umständen und Folgen von Stürzen in Ihrer Einrichtung, mindestens einmal jährlich wertet die PDL die Gesamterhebung aus und stellt im Rahmen des PDCA-Zyklus mögliche Verbesserungsmaßnahmen dar.

Nachbereitung:

- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL

Anlagen

- Gesamtrisikoeerhebung, SIS, Maßnahmenplan
- Beratungsgespräch(Protokoll)
- Sturzprotokoll

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Veränderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2020	06.02.2023	003	4	Verw./MA

2.3 Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege, 2. Aktualisierung 2022

Stand: Juli 2022

Zielsetzung: Jeder pflegebedürftige Mensch mit einem erhöhten Sturzrisiko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze weitgehend verhindert und Sturzfolgen minimiert.

Begründung: Stürze stellen insbesondere für ältere und kranke Menschen ein hohes Risiko dar. Sie gehen häufig mit schwerwiegenden Einschnitten in die bisherige Lebensführung einher, die von Wunden und Frakturen über Einschränkung des Bewegungsradius infolge verlorenen Vertrauens in die eigene Mobilität bis hin zur Aufgabe einer selbstständigen Lebensführung reichen. Durch rechtzeitige Einschätzung der individuellen Risikofaktoren, eine systematische Sturzerfassung, Information, Schulung und Beratung von Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko und ihren Angehörigen sowie eine gemeinsame Maßnahmenplanung und -durchführung kann eine sichere Mobilität gefördert werden.

Struktorkriterien		Prozesskriterien		Ergebniskriterien	
S1	Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Einschätzung eines Sturzrisikos.	P1a	Die Pflegefachkraft identifiziert unmittelbar zu Beginn des pflegerischen Auftrages mittels eines Screenings systematisch das Sturzrisiko aller Menschen mit Pflegebedarf. Kann ein Sturzrisiko nicht ausgeschlossen werden erfasst sie mittels einer verteilten Einschätzung systematisch die individuellen personen-, medikamenten- und umgebungsbezogenen Sturzrisikofaktoren.	E1	Eine aktuelle, systematische Erfassung des individuellen Sturzrisikos liegt vor.
S2a	Die Einrichtung verfügt über eine Verfahrensregel zur Sturzprophylaxe.	P2	Die Pflegefachkraft entwickelt gemeinsam mit dem Menschen mit Sturzrisiko und den Angehörigen sowie den beteiligten Berufsgruppen einen individuellen Maßnahmenplan.	E2	Ein individueller Maßnahmenplan zur Sturzprophylaxe liegt vor. Das individuelle Sturzrisiko sowie die notwendigen Maßnahmen sind allen an der Versorgung beteiligten Personen bekannt.
S2b	Die Pflegefachkraft kennt geeignete Interventionen zur Vermeidung von Stürzen und zur Minimierung sturzbedingter Folgen und verfügt über die Kompetenz zur Planung und Vereinbarung geeigneter Maßnahmen.				
S3	Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Information, Schulung und Beratung bezüglich des Sturzrisikos und geeigneter Interventionen.	P3	Die Pflegefachkraft informiert den pflegebedürftigen Menschen und die Angehörigen über das festgestellte Sturzrisiko und bietet Schulung und Beratung zur Vermeidung von Stürzen an.	E3	Dem pflegebedürftigen Menschen und ggf. den Angehörigen sind das individuelle Sturzrisiko sowie geeignete Maßnahmen zur Sturzprophylaxe bekannt. Die Information, Schulung und Beratung sind dokumentiert.
S4a	Die Einrichtung ermöglicht zielgruppenspezifische Interventionsangebote und gewährleistet geeignete räumliche und technische Voraussetzungen sowie Hilfsmittel für eine sichere Mobilität.	P4a	Die Pflegefachkraft gewährleistet in Absprache mit den beteiligten Berufsgruppen und dem Menschen mit Sturzrisiko gezielte Interventionen auf der Grundlage des Maßnahmenplans.	E4	Interventionen, Hilfsmittel und Umgebung sind dem individuellen Sturzrisiko des pflegebedürftigen Menschen angepasst und fördern eine sichere Mobilität.
S4b	Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Durchführung und Koordination von Interventionen zur Sturzprophylaxe.	P4b	Die Pflegefachkraft sorgt für eine individuelle Umgebungsanpassung sowie für den Einsatz geeigneter Hilfsmittel zur Sturzprophylaxe.		
S5a	Die Einrichtung stellt Ressourcen zur Auswertung und Analyse von Stürzen zur Verfügung.	P5a	Die Pflegefachkraft überprüft gemeinsam mit dem Menschen mit Sturzrisiko und ggf. den Angehörigen den Erfolg und die Akzeptanz der eingeleiteten Maßnahmen und nimmt bei Bedarf Anpassungen am Maßnahmenplan vor.	E5a	Jeder Sturz ist dokumentiert und analysiert. Die eingeleiteten Maßnahmen haben die Mobilität des pflegebedürftigen Menschen gefördert und zur Verhinderung von Stürzen beigetragen.
S5b	Die Pflegefachkraft verfügt über die Kompetenz zur Beurteilung der Effektivität sturzprophylaktischer Maßnahmen und zur Beurteilung der Sturzerfassung und -analyse.	P5b	Die Pflegefachkraft dokumentiert und analysiert jeden Sturz, gebebenfalls mit anderen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen.	E5b	In der Einrichtung liegen Zahlen zu Häufigkeit, Umständen und Folgen von Stürzen vor.

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch Sturzprotokoll	 Intensivpflege-Halle-GmbH
------------------	--	---

Name, Geburtsdatum	Name: _____ Geburtsdatum: _____				
Datum, Uhrzeit und Ort des Sturzes	Datum: _____		Uhrzeit: _____		Ort: _____
Von wem wurde der Patient gefunden?	☐ Mitarbeiter/in	☐ Angehöriger/in	☐ Patient/in	☐ Externe/r	☐ keine
Zeugen des Sturzhergangs(Name, Vorname)	☐ Mitarbeiter/in	☐ Angehöriger/in	☐ Patient/in	☐ Externe/r	☐ keine
Sturzhergang , Begleitumstände, Auslöser, Kleidung, Schuhwerk, Bodenbeschaffenheit, Licht	_____ _____ _____ _____				
Wer hat den Sturzhergang geschildert?	☐ Mitarbeiter/in	☐ Angehöriger/in	☐ Patient/in	☐ Externe/r	☐ keine
Sturzfolgen (Verletzungen, Schmerzen, Bewusstseinsveränderungen, kognitive Veränderungen, Veränderungen der Mobilität, Verunsicherung, Angst)	☐ Verletzungen wo: _____ ☐ Schmerzen wo: _____ _____ _____ _____ _____				
Arzt informiert?	☐ nein ☐ ja, welcher: _____		wann: _____		wie: _____
Sofortmaßnahmen (Schmerzbefragung, Arm/ Beinvergleich, Körpercheck, Hautcheck)	☐ Krankenhauseinweisung ☐ Vitalzeichenermittlung ☐ Wundversorgung _____ _____ _____ _____				

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.02.2023		003	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch Sturzprotokoll	 Intensivpflege-Halle GmbH
------------------	--	---

Angehörige, Betreuer/in informiert	☐ nein ☐ ja, wen: _____ wann: _____ wie: _____
Gesundheitliches Befinden und Aktivität unmittelbar vor dem Sturz	☐ Mobil innerhalb/ außerhalb der Einrichtung ☐ nein ☐ in Begleitung ☐ ohne Begleitung Hilfsmittel _____ Psychisch _____ _____ _____ _____
Bisherige Maßnahmen zur Sturzprophylaxe	☐ alternativ siehe Maßnahmenplan und SIS _____ _____ _____
Weitere Maßnahmen zur Sturzprophylaxe	☐ alternativ siehe Fallbesprechung _____ _____ _____
Lag ein Verschulden einer dritten Person vor?	☐ nein ☐ wenn ja wer, _____ welcher Art: _____
Pflegedienstleitung informiert	Datum: _____ Uhrzeit: _____ wie: _____

Datum

Unterschrift MA

Unterschrift Teamleitung

Unterschrift PDL/stellv. PDL

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.02.2023		003	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

Durchführende:

- Pflegefachkraft (PFK) und Pflegehilfskraft (PHK)

Definition, erhöhtes Sturzrisiko:

„Jeder Mensch hat ein Risiko zu stürzen, sei es durch Unachtsamkeit oder bei einer sportlichen Betätigung. Über dieses alltägliche Risiko hinaus gibt es Stürze, deren Ursache im Verlust der Fähigkeit zur Vermeidung eines Sturzes liegt.“ (Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“, 1. Aktualisierung 2013)

Pflegeziel:

Jeder Patient mit einem erhöhten Sturzrisiko erhält eine Sturzprophylaxe, die Stürze weitgehend verhindert und Sturzfolgen minimiert.

personenbezogene Risikofaktoren

Beeinträchtigung funktioneller Fähigkeiten bspw. Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens, Beeinträchtigung sensomotorischer Funktionen bspw. Einschränkungen der Gehfähigkeit oder Balancestörungen, Gesundheitsstörungen, die mit Schwindel, kurzzeitigem Bewusstseinsverlust oder ausgeprägter körperlicher Schwäche einhergehen, Depression und kognitive Beeinträchtigungen, Kontinenzprobleme, Sehbeeinträchtigungen, Sturzangst, Stürze in der Vorgeschichte

Medikamentenbezogene Sturzrisikofaktoren

Antihypertensiva (blutdrucksenkende Mittel), Polypharmazie (mehr als 4 verschiedene Medikamente), Psychotrope Medikamente (bspw. Psychopharmaka)

Umgebungsbezogene Sturzrisikofaktoren

freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM), unangepasstes Schuhwerk, Gefahren in der Umgebung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung durch den Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen
- Patient, ggf. Angehörige informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Durchführung:

- die erste pflegefachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zu den individuellen pflegesensitiven Risiken und Phänomenen (ja-nein) ergibt sich aus den Erkenntnissen der Situationseinschätzung in den Themenfeldern durch die PFK unter der Rubrik relevantes Risiko und Phänomen in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS).
- Wird die Kategorie von der PFK mit „nein“ angekreuzt liegt aus pflegefachlicher Sicht kein Sturzrisiko vor, es werden keine prophylaktischen Maßnahmen geplant und umgesetzt.
- Wird die Kategorie „ja“ angekreuzt, muss die PFK zusätzlich eine Entscheidung zu der Kategorie „weitere Einschätzung notwendig“ (ja-nein) treffen, um festzulegen, ob hierzu aus fachlicher Sicht die Notwendigkeit für die Maßnahmenplanung besteht. Für die Bewertung sind die dargestellten Risiken und Ursachen des aktuellen Nationalen Expertenstandards heranzuziehen.
- tritt Sturzgefahr als Phänomen später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

- ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben und auf der SIS angekreuzt, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen
- das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist zu beachten, bei Einbindung von Angehörigen ist vorher die Genehmigung durch den Patienten einzuholen

Maßnahmen der Sturzprophylaxe können sein:

- Patienten und Angehörige sind über Sturzrisiken aufzuklären und zu beraten
- Feststellung von Vorlieben bzw. Ablehnungen im Rahmen der Umsetzung sturzprophylaktischer Maßnahmen
- externe Personen wie der Arzt/Augenarzt bzw. Physiotherapeut/Ergotherapeut sind über das Sturzrisiko zu informieren, zu weiteren individuell notwendigen Maßnahmen ist sich abzustimmen
- Die PFK koordiniert notwendige Aktivitäten mit Dritten und informiert bei Notwendigkeit die PDL
- im Rahmen des Entlassungsmanagement in andere Versorgungsformen ist auf das Sturzrisiko hinzuweisen (prophylaktische Maßnahmen oder ggf. zu unterlassende Maßnahmen)
- der Patient/Angehörige ist bei der Umsetzung zu unterstützen
- Beobachtung und pflegfachliche Bewertung von Beinahe-Stürzen
- Nutzung aller Möglichkeiten der Förderung von Mobilität (bspw. innerhalb pflegerischer Maßnahmen, zusätzliche Betreuungsleistungen, Einbeziehung von Angehörigen etc.)
- Schaffung der Möglichkeit zur Teilnahme an Kursen zur Förderung von Kraft und Balance, Durchführung multimedialer bzw. multimodularer Kurse (aus verschiedenen Komponenten zusammenhängendes Training über einen längeren Zeitraum), intern/extern
- Anregung zur Überprüfung und Anpassung der Medikation durch den Arzt, Anwendung der „10-R-Regel zur qualitätsgesicherten Medikamentengabe“
- Verbesserung der Sehfähigkeit, Unterstützung bei der Anpassung von neuen Brillen bzw. Gläsern
- Die PFK empfiehlt mögliche Anpassungen der Umgebung z. B. Überprüfung und Anpassung der Lichtverhältnisse, der Sitzmöbel, des Bettes, der Toilette, der Dusche oder Badewanne und des Fußbodens sowie das Anbringen von Haltegriffen, Beseitigung von Stolperfallen, Einsatz geeigneter Hilfsmittel, Benutzung rutschfester Unterlagen
- **Hilfsmittel zur Sturzprävention könnten sein:**
Gehhilfen: verschiedene Gehstöcke, Rollatoren, Stoppersocken, Schuhspikes,
Mobilitätshilfen: höhenverstellbares Bett, WC-Sitzerhöhung, Badewannen-Einstiegshilfe, Stütz- und Haltegriffe
Alltagshilfen: lange Schuhlöffel, Strumpfanzieher, Greifzange, Badewannensitz
Hebehilfen: Mobilisationsgürtel, Rutschbrett, Aufstehhilfe, Lifter
technische Hilfen: Alarmgeber, Falldetektoren, Sensormatten, Bewegungsmelder
Reduktion von Verletzungen: Hüftprotektoren, Sturzhelme, Niedrigbetten, Auffangmatten
- Anbieten von Schulungen/ Einweisungen in die bewusste und ordnungsgemäße Handhabung von Hilfsmitteln (bspw. Rollatoren und andere Hilfsmittel etc.)
- Anpassung Schuhwerk, Empfehlungen für besonderes Schuhwerk

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 23	Bezeichnung des Dokumentes (entbürokratisierte Variante): Sturzprophylaxe in Anlehnung an den Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ (2013)	

- Unterstützung bei Toilettengängen
- im Ausnahmefall kann es im Rahmen der Sturzprophylaxe auch zum bewussten Einsatz freiheitseinschränkender/freiheitsentziehender Maßnahmen kommen, hierbei ist nach dem hierfür geltenden Standard zu verfahren – besitzt der Patient keine Eigenbewegung mehr kann das Ziehen des Bettgitters als Maßnahme der Sturzprophylaxe geplant werden ansonsten ist der Einsatz von FEM im Rahmen der Sturzprophylaxe nicht zulässig

nach einem Sturz:

- der Patient ist anzusprechen, die Vitalzeichen sind zu erheben, lebensrettende Maßnahmen sind umzusetzen
- bei Notwendigkeit sofort den Notarzt verständigen
- es ist ein Sturzprotokoll zu führen und umgehend an die PDL weiter zu leiten, die Sturzrisikokala ist zu aktualisieren
- die PDL führt eine Gesamtliste der Sturzereignisse mit der Darstellung von Umständen und Folgen von Stürzen im Pflegedienst, mindestens einmal jährlich wertet die PDL die Gesamterhebung aus und stellt im Rahmen des PDCA-Zyklus mögliche Verbesserungsmaßnahmen dar

Nachbereitung:

- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. die diensthabende PFK

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA